Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Judicial da Comarca de Venâncio Aires

Rua Berlim da Cruz, 1306 - Bairro: Centro - CEP: 95800000 - Fone: (51) 30985597 - Email: frvaires1vjud@tjrs.jus.br

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE Nº 5003353-32.2021.8.21.0077/RS

REQUERENTE: CAIO VEIGA FOCKING
ADVOGADO(A): IANE PONTES VIEIRA (OAB SP332049)

REQUERIDO: UNIMED - COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.
ADVOGADO(A): JESSICA CAMILA MACHADO GERHARD (OAB RS118068)
ADVOGADO(A): MAGDA MARIA PINTON TITON (OAB RS063310)
ADVOGADO(A): CHRISTIANO VOLKEN NUNES (OAB RS062809)
ADVOGADO(A): JHONY RODRIGUES PEREIRA (OAB RS098431)

SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência intentada por **Caio Veiga Focking,** neste ato representado por sua genitora, Caroline Veiga, em face de **Unimed Cooperativa de Serviços de Saúde dos Vales do Taquari e Rio Pardo Ltda**, todos qualificados em peça inicial. Relatou é portador das patologias catalogadas nos CID10 F84 - Transtorno do Espectro Autista e CID10 F90 - Déficit de Atenção e Hiperatividade. Afirmou que fez tratamento com medicamento Aripiprazol 20 mg, mas não teve boa adesão, impactando negativamente em sa vida e de seus cuidadores. Que necessitar fazer uso de OIL USA Hemp CBD 300 mg (dois frascos ao mês), inexistindo fármacos iguais e com a mesma eficácia no Sistema Único de Saúde. Afirmou não possuir condições financeiras de adquirir o medicamento. Postulou o seguinte: **(a)** em tutela de urgência, seja determinado que a requerida autorize o fornecimento/custeio/compra do medicamento OIL USA Hemp CBD 300 mg (cannabidiol); **(b)** o estabelecimento de multa diária em caso de não cumprimento da obrigação; **(c)** a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); **(d)** a procedência da demanda; e **(e)** o deferimento do benefício da gratuidade judiciária. Juntou procuração e documentos.

Concedido o benefício da gratuidade judiciária e determinada a apresentação do contrato do plano de saúde firmado (*evento 3, DESPADEC1*).

Juntado o contrato.

Em decisão interlocutória restou indeferida a tutela de urgência.

Citada, a requerida apresentou contestação, oportunidade em que impugnou valor da causa apresentado pelo autor, sustentando inexistir documentos comprobatórios do custo do tratamento pleiteado, entendendo pela aplicação da soma entre os valores de alçada e dos danos morais pretendidos. No mérito alegou que medicamentos importados que não sejam nacionalizados não são de cobertura obrigatória dos planos de saúde. Que o medicamento requerido não possui registro na ANVISA, situação que o caracteriza como importado não nacionalizado. Referiu, ainda, que a Lei de Planos de Saúde estabelece não serem de cobertura assistencial obrigatória os medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os fármacos antineoplásticos. Sustentou que improcede o pleito indenizatório, pois afirma que restou demonstrado que houve base legal e contratual para a negativa assistencial de cobertura do cannabidiol. Postulou a improcedência da demanda. Juntou procuração e documentos. Juntou procuração e documentos.

Em réplica o autor rechaçou os argumentos postos em contestação, requerendo a procedência da demanda. Juntou orçamento do medicamento.

Intimadas as partes quanto ao interesse na produção de provas.

Em manifestação a requerida postulou o julgamento antecipado da demanda.

O autor informou que não possui interesse na produção de outras provas.

O Ministério Público se manifestou pela realização de prova pericial, pela consulta ao E-Natjus para apresentação de parecer técnico sobre a eficácia do medicamento pleiteado e pela expedição de ofício à ANS solicitando informações sobre o fármaco no âmbito da saúde suplementar.

Restou acolhida a manifestação do Ministério Público, sendo determinada consulta ao E-Natjus para apresentação de parecer técnico (*evento 36, DESPADEC1*).

Certificado que, em cumprimento a determinação, o Cartório não possuía acesso ao E-Natjus, sendo juntado aos autos Nota Técnica de consulta pública desse sistema.

Em manifestação a requerida, em suma, reiterou os fundamentos apresentados em peça contestacional, requerendo o prosseguimento do feito.

O Ministério Público se manifestou pela improcedência da demanda.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o breve relatório.

Decido.

Da preliminar de impugnação ao valor da causa

Em demandas que objetivam o fornecimento de medicamento ou tratamento por prazo indeterminado ou superior a um ano, o valor atribuído à causa será referente ao custo de uma prestação anual, como previsto no artigo 292, parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil (Agravo de Instrumento, Nº 53565261320238217000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 21-11-2023).

No caso em comento, os documentos médicos apresentados não esclarecem a duração do tratamento postulado pelo autor (se por período indeterminado ou determinado), de modo que o valor da causa, nos termos da fundamentação supra, deve corresponder ao custo de um ano e, ainda que se considerasse a informação prestada em exordial, prevendo a necessidade de *"24 frascos/ano e 48 frascos totais"*, igualmente aplicável a previsão do parágrafo 2º do artigo 292 do Código de Processo Civil, porquanto superior a um ano.

Assim, tendo em consideração o orçamento apresentado com a réplica, tenho que o valor da causa deve ser de R$ 32.973,12 (trinta e dois mil novecentos e setenta e três reais e doze centavos), montante referente a R$ 17.973,12 (dezessete mil novecentos e setenta e três reais e doze centavos) de 24 frascos do medicamento, o necessário para um ano de tratamento, e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) aos danos morais pretendidos.

Destarte, acolho a preliminar e corrijo o valor da causa para R$ 32.973,12 (trinta e dois mil novecentos e setenta e três reais e doze centavos).

Do mérito

Cumpridas todas as etapas legalmente previstas no procedimento, entendo estar o feito apto a julgamento, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sem qualquer nulidade a ser sanada.

Quanto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos seguro e de planos de saúde, cumpre mencionar que inexiste dúvida quanto a sua aplicação, cuidando-se de entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2010, na Súmula 469, que assim dispõe: *"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde"*. Constato que tal entendimento restou mantido quando da edição da Súmula 608, que cancelou a anterior e somente acrescentou a exceção para os planos administrados por entidades de autogestão.

Desse modo, os contratos de seguro e de plano assistência à saúde devem se submeter aos regramentos previstos na legislação consumerista, com a finalidade de evitar eventual desequilíbrio entre as partes, considerando eventual hipossuficiência do consumidor em face do fornecedor.

Com efeito, estando os contratos submetidos às disposições desta norma, aplicável, dentre outras, as seguintes regras: *"As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor"* (artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor). E, considerar-se-ão abusivas aquelas que (suprimi):

> Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...]
>
> IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; [...]
>
> XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor; [...]
>
> § 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:
>
> I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;
>
> II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;
>
> III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Para corroborar, cito entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça Gaúcho:

> APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. **PLANO DE SAÚDE.** AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE VALORES. APOSENTADORIA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. MANUTENÇÃO DO BENEFICIÁRIO NO PLANO. ARTIGO 31 DA LEI N.º 9.656/98. PLANO ESPECÍFICO PARA INATIVOS. POSSIBILIDADE. **1. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Súmula 608 do STJ. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.** 2. É possível a manutenção do titular e seus dependentes por prazo indeterminado nos contratos de plano de saúde firmado por empresa em que o titular tenha trabalhado, desde que assuma o pagamento integral das mensalidades, exegese do art. 31 da Lei nº 9.656/98. 3. Hipótese de inclusão do autor em plano específico para inativos, com manutenção das condições de cobertura, porém com diferentes critérios para estabelecimento do valor das mensalidades. Possibilidade, nos termos da RN 279 da ANS. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70083529487, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 27-05-2020). Grifei.

Superada a questão, passo à análise das coberturas médicas pelos planos assistenciais à saúde.

No ponto, os procedimentos médicos a serem amparadas pelos planos de saúde estão sujeitos a um rol mínimo editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que possui como exceção de previsão as hipóteses elencadas no artigo 10 da Lei de Plano de Saúde e não podem excluir aquelas constantes no artigo 12 do mesmo diploma legal. Entretanto, nada impede, por óbvio, que os contratos dilatem a cobertura mínima, cobrindo, inclusive, as situações do artigo 10 anteriormente citado.

Saliento, ainda, conforme jurisprudência da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça deste Estado, que está alinhada a redação dada pela Lei n. 14.454/2022, que alterou o parágrafo 12 do artigo 10 da Lei n. 9.656/1998, *"O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica"* para a cobertura dos planos privados de saúde, não constituindo, assim, caráter taxativo, mas sim exemplificativo.

Em que pese tal atualização legislativa, a Lei n. 9.656/1998 possui previsão expressa das possibilidades dos planos assistenciais em excluir de sua cobertura determinados tratamentos, dentre os quais estão o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar (com exceção dos antineoplásicos domiciliares de uso oral e fármacos em regime de *home care*). Transcrevo (suprimi):

> Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
>
> V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizado;
>
> VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12; [...]
>
> Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:
>
> I - quando incluir atendimento ambulatorial: [...]
>
> c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; [...]
>
> II - quando incluir internação hospitalar: [...]
>
> g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;

Em vista disso, em consonância com entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, a recusa na cobertura pelos planos de assistência à saúde de medicamentos de uso domiciliar, que não antineoplásicos e de uso em regime de *home care*, é legítima, vejamos:

> PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIABETES. EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO DE GLICOSE. **ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS.** EXCEÇÃO. **TRATAMENTO DOMICILIAR**. EQUIPAMENTO NÃO LIGADO A ATO CIRÚRGICO. RECUSA DE COBERTURA DEVIDA.
> **1. Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.**
> 2. Hipótese em que são pleiteados equipamentos para monitoramento de glicose, os quais são caracterizados como tratamento domiciliar, porquanto podem ser adquiridos diretamente pelo paciente em farmácias de acesso público, para ser autoadministrado por ele em seu ambiente domiciliar, sem a necessidade de intervenção médica, razão pela qual é devida a recusa de cobertura.
> 3. Agravo interno desprovido.
> (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.964.771/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.). Grifei.
>
> CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. **CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÁRMACOS DE USO DOMICILIAR NÃO PREVISTOS EM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E QUE NÃO CORRESPONDEM A ANTINEOPLÁSICOS ORAIS E CORRELACIONADOS À MEDICAÇÃO ASSISTIDA, NEM AOS CONSTANTES DO ROL DA ANS. DEVER DE COBERTURA AFASTADO.** DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
> 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
> **2. É lícita a recusa de cobertura de medicamento de uso domiciliar que não se enquadre como antineoplásico oral, de controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, a medicação assistida (home care) e os constantes do correspondente rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ficando ressalvadas apenas as hipóteses de pagamento por liberalidade da operadora ou por força de previsão no contrato principal ou acessório do plano de saúde.**
> 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
> 4. Agravo interno não provido.
> (AgInt no REsp n. 1.981.905/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.). Grifei.

Assim, os planos de assistência à saúde, salvo contratação que estenda a abrangência da cobertura, não possui obrigação de fornecer/cobrir medicamentos de uso domiciliar, que é a hipótese dos autos.

In casu, o autor requereu que o plano de saúde (requerido) cubra o medicamento OIL USA Hemp CBD 3000mg/60ml (canabis) é um medicamento de uso domiciliar, ou seja, a ser usado externamente a unidades de saúde.

Dito isso, ante a ausência de previsão contratual para a cobertura de medicação de uso domiciliar, que se encontra excluída das hipóteses legais de cobertura, não há como se falar em dever da requerida em fornecer o fármaco, figurando legítima sua recusa. Por fim, colaciono, para melhor elucidar, a cláusula contida no contrato firmado entre as partes:

> **VI. EXCLUSÕES DE COBERTURA**
>
> **Cláusula 11**: Estão expressamente **excluídos** de cobertura, sobre eles não assumindo a **CONTRATADA** qualquer responsabilidade, os seguintes fornecimentos:
> **I. tratamento clínico ou cirúrgico experimental, qual seja aquele que:**
> **a) emprega medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados ou regularizados no Brasil;**
> **b) são expressamente considerados, como experimentais, pelo Conselho Federal de Medicina, ou pelo Conselho Federal de Odontologia; e**
> **c) não conte com a indicação, para o tratamento, na bula, ou mesmo no manual registrado perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (internacionalmente conhecido como uso '*off-label*').**
> **II. procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses, próteses e materiais especiais para o mesmo fim, ou seja, aqueles que não visam restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita;**
> **III. inseminação artificial, definida como técnica de reprodução assistida que inclui a manipulação de oócitos e esperma para alcançar a fertilização, por meio de injeções de esperma intracitoplasmáticas; transferência intrafalopiana de gameta; doação de oócitos; indução da ovulação; concepção póstuma, recuperação espermática ou transferência intratubária do zigoto, ou outras técnicas similares;**
> **IV. tratamentos de rejuvenescimento ou emagrecimento com finalidade estética, assim como em '*spas*', clínicas de emagrecimento, clínicas de repouso, estâncias hidrominerais e clínicas para acolhimento de idosos;**
> **V. fornecimento de medicamentos e produtos importados (incluindo OPME) que não estejam nacionalizados, ou seja, produzidos fora do país e sem registro em vigor na ANVISA, bem como todo e qualquer tipo de medicamento, mesmo prescrito durante a internação hospitalar, contanto que sua efetividade ou eficácia haja sido reprovada pela Comissão de Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde;**
> **VI. fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, assim entendidos aqueles que prescritos pelo médico assistente/cooperado sem indicação de que sejam ministrados em ambiente externo ao da unidade de saúde, respeitadas as exceções previstas na regulamentação da ANS vigente;**
> **VII. fornecimento de próteses, órteses e materiais de qualquer natureza não ligados ao ato**

No mesmo sentido, colaciono entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que, além de recentíssimo, muito se assemelha ao presente caso:

> APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA. EPILEPSIA HIDROCEFALIA (CID F84.0, G40.8 E G91.8). **MEDICAMENTO CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DO DEVER DE COBERTURA Trata-se de ação de obrigação de fazer, através da qual a parte autora postula cobertura do fármaco Canabidiol, 200mg/ml, julgada improcedente na origem.** Ao atender o comando do art.197 da Carta Constitucional a Lei n. 9656/98, disciplinou os planos e seguros privados de assistência à saúde, como forma de complementar o Sistema Público Saúde (SUS). Com esse propósito foi criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), via Lei n.9961/00, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, de modo a contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no País. Compete a ANS (art.4º), dentre outras diretrizes, elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirá referência básica de assistência (inc.III), com o escopo de garantir um plano de saúde e assistência mínimo de caráter privado, atento às evoluções tecnológicas, sem prejuízo da faculdade da contratação de cobertura mais extensa. Imprescindível considerar que afora a instituição do Plano-Referência de Assistência à Saúde, forte no art.10 da Lei n.9656/98, que garante o mínimo assistencial de caráter negocial privado, há, igualmente, a faculdade de o consumidor contratar plano de assistência à saúde de natureza superior e com maior cobertura, consoante faculta o art.12 do mesmo Diploma Legal. Ambos são regulados pela ANS, a diferença é o valor da contraprestação, o que infirma concluir que é inexorável considerar a natureza da negociação e a espécie de plano assistencial privado em litígio. O Plano de Referência estabelece exceções (art.10, incs.I a X, Lei n.9656/98), ou seja, hipóteses de não-cobertura, ressalvando-se a contratação facultativa complementar (art.12) e admissão por regulação da ANS (art.10,§1º), que poderá inclusive abranger transplantes e procedimentos de alta complexidade (art.10,§4º). Como consectário, não há como fugir do caráter limitador e taxativo do rol atualizado da ANS, agência reguladora, veiculado via Resoluções, sob pena de colocar em risco a saúde financeira e existencial dos próprios Planos Privados de Saúde. **No caso telado, o autor, menor, foi diagnosticado com transtorno espectro autista, epilepsia hidrocefalia (CID F84.0, G40.8 e G91.8), conforme atestados médicos da neuropediatra, Dra. Camila dos Santos Halal – CRM 31885 (evento 1 – LAUDOL10 e LAUDO 11 – origem), necessitando do tratamento com Canabidiol, 20mg/ml, da dose diária de até 0,5ml - 1 frasco ao mês, conforme receita médica (evento 1 – RECEIT121 – origem), entretanto, tal medicamento não se encontra listado no rol taxativo da ANS e, considerando que a parte autora não se enquadra nas exceções previstas para cobertura de tratamento domiciliar, tenho que a negativa de cobertura do referido medicamento não se mostra abusiva. A situação telada não se enquadra nas exceções que permitem a concessão dos medicamentos domiciliares (antineoplásicos e utilizados em home care), considerando que o medicamento receitado não está listado no Rol da ANS e é para uso doméstico, de modo que não estão cobertos pelos planos de saúde, consoante recentes julgados do egrégio STJ.** Assim, é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021).APELAÇÃO DESPROVIDA(Apelação Cível, Nº 50191164420218210022, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 31-08-2023). Grifei.

Improcedente, portando, a demanda.

Com isso, igualmente não há de se falar em danos morais ante a negativa de cobertura do tratamento pleiteado pelo plano assistencial.

Dispositivo

Diante disso, fulcro no artigo 487, inciso I, o Código de Processo Civil, **julgo improcedentes** os pedidos formulados por **Caio Veiga Focking,** neste ato representado por sua genitora, Caroline Veiga, em face de **Unimed Cooperativa de Serviços de Saúde dos Vales do Taquari e Rio Pardo Ltda.**

Condeno o sucumbente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios aos procuradores da requerida, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspensa, contudo, sua exigibilidade ante a gratuidade judiciária concedida.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Oportunamente, proceda-se na baixa.

Documento assinado eletronicamente por **JOAO FRANCISCO GOULART BORGES, Juiz de Direito**, em 18/1/2024, às 16:30:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10052533918v24** e o código CRC **177cc93f**.